

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL TEPT PARA EL DSM-5 (PCL-5)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Severidad y Cribado de Trastorno por Estrés Postraumático

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Lista de Verificación del Trastorno por Estrés Postraumático para el DSM-5 (PCL-5).
Nombre Original (Inglés)	<i>Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5)</i>
Autores Originales	Drs. Frank W. Weathers, Brett T. Litz, Terence M. Keane, Patrick A. Palmieri, Brian P. Marx y Paula P. Schnurr (2013), National Center for PTSD.
Adaptaciones Españolas	Miles et al. (2015); Cova et al. (2017); Carvajal et al. (2017).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Diagnóstico y monitorización del trauma psicológico.
Tipo de Instrumento	Autoinforme estructurado de 20 reactivos tipo Likert (0 a 4) referidos a un acontecimiento traumático índice.
Población Diana	Adolescentes y adultos (>= 16 años) expuestos a sucesos de amenaza vital o daño grave.
Tiempo de Administración	5 a 10 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público (US Department of Veterans Affairs / National Center for PTSD). Uso libre en clínica e investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DEL TRAUMA

La PCL-5 actualiza la clásica escala PCL a los criterios diagnósticos del DSM-5, los cuales redefinieron el TEPT eliminando la respuesta subjetiva peritraumática (Criterio A2) y ampliando la fenomenología a 4 conglomerados de síntomas. El instrumento evalúa la presencia de huellas traumáticas derivadas de la exposición a muerte real o amenaza de muerte, lesiones físicas graves o agresión sexual (Criterio A).

En el plano neurobiológico, el TEPT se caracteriza por una disfunción del condicionamiento del miedo originada en una hiperreactividad amigdalina unida a una hipoactivación de la corteza prefrontal medial y cingulada anterior (falla del control descendente de la respuesta defensiva). Asimismo, el volumen y funcionamiento disminuido del hipocampo impiden una adecuada contextualización espacio-temporal del recuerdo, provocando que los estímulos asociados al trauma reactiven vivencias sensoriales intrusivas con sensación de presente ("aquí y ahora").

3. CLUSTERS SINTOMÁTICOS DEL DSM-5 Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Cluster DSM-5	Ítems	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Semiológico
Cluster B: Intrusión	1 al 5	0 a 20	Recuerdos intrusivos involuntarios (1), sueños/pesadillas recurrentes (2), reacciones disociativas/ <i>flashbacks</i> (3), malestar ante recordatorios (4) y reactividad fisiológica intensa (5).
Cluster C: Evitación	6 y 7	0 a 8	Evitación activa de pensamientos, sentimientos o recuerdos del suceso (6) y evitación de lugares, personas, objetos o actividades recordatorias (7).
Cluster D: Cognición y Ánimo Negativo	8 al 14	0 a 28	Amnesia disociativa peritraumática (8), creencias negativas globales sobre uno mismo o el mundo (9), distorsiones sobre la culpa (10), emociones negativas crónicas (11), desinterés/anhedonia (12), desapego de otros (13) e incapacidad para sentir afecto positivo (14).
Cluster E: Hiperactivación / Reactividad	15 al 20	0 a 24	Irritabilidad/agresividad (15), conductas temerarias o autodestructivas (16), hipervigilancia (17), respuesta de sobresalto exagerada (18), dificultad de concentración (19) y problemas de sueño (20).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Sobresaliente consistencia interna global: alfa de Cronbach de 0.94 a 0.96; alfas por clusters: B (0.88), C (0.86), D (0.89) y E (0.87) en muestras hispanohablantes (Cova et al., 2017).
Sensibilidad y Especificidad	Sensibilidad del 88% al 94% y especificidad del 85% al 90% para el punto de corte clínico estándar (31 a 33 puntos) frente a la entrevista CAPS-5.
Validez Concurrente	Elevadas correlaciones con la Escala de Impacto del Evento Revisada (IES-R $r = 0.85$), PHQ-9 ($r = 0.74$) y GAD-7 ($r = 0.76$).
Sensibilidad al Cambio	Herramienta gold-standard para ensayar mejoría postratamiento en EMDR o terapia de exposición prolongada. Una reducción de ≥ 10 puntos indica cambio clínicamente significativo.
Estructura Factorial	El modelo de 4 factores correlacionados del DSM-5 muestra un ajuste excelente en análisis confirmatorios (CFI = 0.95; RMSEA = 0.05).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y MÉTODOS DE PUNTUACIÓN

Cada reactivo se califica según el grado de molestia experimentado durante el **último mes**:

- **0** = Nada | **1** = Un poco | **2** = Moderadamente | **3** = Mucho | **4** = Extremadamente.
- **Método Cuantitativo:** Suma total de los 20 ítems (Rango: **0 a 80 puntos**).
- **Método Categorical DSM-5:** Se considera presente un síntoma si la respuesta es ≥ 2 ("**Moderadamente**"). Para cumplir el criterio sintomático provisional de TEPT se requiere:
 - Al menos 1 síntoma del Cluster B (ítems 1–5).
 - Al menos 1 síntoma del Cluster C (ítems 6–7).
 - Al menos 2 síntomas del Cluster D (ítems 8–14).
 - Al menos 2 síntomas del Cluster E (ítems 15–20).

6. PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (NATIONAL CENTER FOR PTSD)

Nivel	Puntuación	Diagnóstico Provisional	Recomendación Asistencial
Subclínico	0 a 20	Impacto postraumático mínimo	Respuesta adaptativa de recuperación espontánea. No requiere intervención formal; monitorización según evolución.
Leve	21 a 30	Sintomatología traumática leve	Reacción de estrés postraumático no sindrómica. Apoyo psicológico básico y educación en normalización de síntomas.
Clínico	31 a 45	Probable TEPT (Corte ≥ 31–33)	Diagnóstico presuntivo de TEPT. Confirmación con entrevista clínica estructurada (CAPS-5) e inicio de terapia de trauma de primera línea.
Severo	46 a 80	TEPT gravemente incapacitante	Afectación global masiva de todas las áreas funcionales. Alto riesgo de autolisis, disociación y abuso de sustancias. Derivación prioritaria.

PUNTO DE CORTE PROMEDIO INTERNACIONAL (PCL-5 ≥ 33): El punto de corte ≥ 33 optimiza la especificidad para evitar falsos positivos en atención médica y forense. En entornos de cribado militar o de víctimas de violencia aguda, un punto de corte de ≥ 31 maximiza la sensibilidad de detección precoz.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO TRAUMA-INFORMADO

EVALUACIÓN DEL SUBTIPO DISOCIATIVO DEL DSM-5: • **Despersonalización:** Sentirse como un observador externo del propio cuerpo o mente (preguntar explícitamente si el ítem 3 se acompaña de desconexión corporal). • **Desrealización:** Sensación de que el entorno es irreal, como un sueño o una película. • **Implicancia Terapéutica:** Los pacientes con subtipo disociativo no toleran la exposición prolongada directa sin una fase previa intensiva de estabilización emocional, titulación y técnicas de anclaje sensorial (*grounding*).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: VÍCTIMA DE ACCIDENTE DE TRÁFICO

Paciente: Varón de 34 años, camionero, superviviente de una colisión múltiple ocurrida 4 meses antes en la que falleció su acompañante. Remitido por mutua de accidentes laborales por incapacidad para reincorporarse y crisis de angustia en carretera. **Puntuación PCL-5 Total: 48 puntos (Nivel Severo — Probable TEPT Crónico).** • **Desglose por clusters:** Cluster B = 14 pts (pesadillas casi diarias y flashbacks al escuchar chirridos de frenos); Cluster C = 8 pts (máxima evitación: niega viajar en coche como pasajero y apaga la televisión si hay noticias de tráfico); Cluster D = 14 pts (creencia persistente de «fui el culpable de su muerte», anhedonia severa y embotamiento afectivo); Cluster E = 12 pts (hipervigilancia al cruzar calles, sobresalto exagerado e insomnio terminal). **Conducta Asistencial:** Se diagnostica TEPT crónico con ideas de culpa peritraumática. Se inicia Terapia de Procesamiento Cognitivo (CPT) combinada con Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR). A las 12 semanas, la puntuación PCL-5 desciende a 18 puntos (reducción de 30 puntos, remisión clínica) y se logra la reanudación progresiva de la conducción.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EVALUACIÓN DE CONDUCTA AUTOLÍTICA

ALERTA DE RIESGO SUICIDA EN TEPT El TEPT severo incrementa drásticamente el riesgo de conducta suicida debido a la combinación de culpa traumática (ítem 10), dolor psíquico crónico (ítem 11) e impulsividad temeraria (ítem 16).

CONSUMO COMÓRBIDO DE SUSTANCIAS Descartar sistemáticamente automedicación con alcohol o sedantes empleada para mitigar las intrusiones del Cluster B o facilitar la conciliación del sueño.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Weathers, F. W., Litz, B. T., Keane, T. M., Palmieri, P. A., Marx, B. P., & Schnurr, P. P. (2013). *The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5)*. National Center for PTSD.
2. Blevins, C. A., Weathers, F. W., Davis, M. T., Witte, T. K., & Domino, J. L. (2015). The Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5): Development and initial psychometric evaluation. *Journal of Traumatic Stress*, 28(6), 489–498.
3. Cova, F., Rincón, P. P., Bustos, C., Nieto, C., & Castro, C. (2017). Propiedades psicométricas de la escala PCL-5 en población chilena expuesta a trauma. *Revista Chilena de Neuro-psiquiatría*, 55(4), 241–251.
4. Bovin, M. J., Marx, B. P., Weathers, F. W., Gallagher, M. W., Rodriguez, P., Schnurr, P. P., & Keane, T. M. (2016). Psychometric properties of the PTSD Checklist for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition (PCL-5) in veterans. *Psychological Assessment*, 28(11), 1379–1391.